

Rapid *cycling*

Szybkozmienna postać BD: ≥ 4 epizody na rok. Trudniejsza w leczeniu, większe ryzyko nawrotów. Specyfika, czynniki wyzwalające, dostosowane podejście.

CZAS: 15 min — psychoedukacja **CHARAKTER:** przebieg, leczenie

ŹRÓDŁO: Yatham CANMAT (2018); Schneck (2008)

JAK UŻYWAĆ

Rapid cycling rozpoznajemy gdy ≥ 4 **epizody nastroju w ciągu roku** (DSM-5, kryteria Dunner & Fieve 1974). Może być przejściowy lub utrwalony. Leczenie różni się od „klasycznego” BD: antydepresanty często *nasilają* cykl, walproinian i lamotrygina są skuteczniejsze niż lit, kluczowe są *rytmy społeczne* i sen. Zidentyfikuj czynniki nasilające — wiele jest modyfikowalnych.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Schneck i wsp. (2008, STEP-BD): „*antydepresanty są **najczęstszym** nieoczywistym czynnikiem indukującym rapid cycling. U pacjentów z 4+ epizodami w roku redukcja antydepresantów obniża częstość epizodów o 50%*”. Yatham CANMAT (2018): walproinian (Depakine) jest pierwszą linią w rapid cycling, lamotrygina szczególnie skuteczna w cyklach z dominacją depresji.

01 ? Czynniki nasilające rapid cycling

Wiele jest modyfikowalnych. Sprawdź, które dotyczą Ciebie.

☐ **Antydepresanty** — szczególnie SNRI, trójcykliczne. Konsultacja: redukcja lub odstawienie.

☐ **Niedoczynność tarczycy** — subkliniczna obniżona TSH. Sprawdź — leczenie zmienia obraz.

☐ **Substancje psychoaktywne** — kokaina, amfetamina, ecstasy, kawa w nadmiarze.

☐ **Zaburzenia snu** — chroniczna bezsenność, praca zmianowa, częste podróże ze zmianą stref czasowych.

☐ **Niedobory hormonalne** — ciąża, perimenopauza, zaburzenia osi nadnerczy.

☐ **Chroniczny stres** — nierozwiązany konflikt, niestabilna sytuacja życiowa, traumatyczne wydarzenia.

02 🌿 Leczenie — specyfika rapid cycling

✓ SKUTECZNE

Walproinian — pierwsza linia (Yatham 2018) · **Lamotrygina** — szczególnie w cyklach z depresją · **Kwetiapina** — dodatkowa linia · **Olanzapina + fluoksetyna** (Symbyax) — depresja w BD I.

⚠ OSTROŻNIE / UNIKAĆ

Antydepresanty — często nasilają cykl · **Lit** — mniej skuteczny niż w klasycznym BD · **Karbamazepina** — interakcje, mniej tolerowana.

03 ✓ Pozafarmakologiczne wsparcie

Te elementy działają silniej w rapid cycling niż w klasycznym BD.

1 · IPSRT (FRANK 2005)

Terapia rytmów społecznych i interpersonalnych.
Konkretny harmonogram (pora wstawania, posiłków, ruchu, snu). W rapid cycling — wyraźna poprawa.

2 · CBT NA BEZSENNOŚĆ

CBT-I dla pacjentów z BD i rapid cycling. Higiena snu + restrukturyzacja przekonań o śnie. Sen jest fundamentem stabilizacji.

3 · MOOD CHARTING

Codzienne wizualizowanie wahań (eMoods, Daylio, papier). Po 3 miesiącach widać wzorce — co wyzwała, co stabilizuje.

4 · ELIMINACJA STYMULANTÓW

Kofeina po południu, alkohol, papierosy w nadmiarze. Każdy z nich może wyzwać cykl.

5 · SPRAWDZENIE TARCZYCY

Co 6 miesięcy: TSH, T3, T4, anty-TPO. Subkliniczna niedoczynność występuje u 25% osób z rapid cycling.

6 · ZMNIEJSZENIE ZMIENNOŚCI

W pracy: stałe godziny, jeden dom, regularne posiłki. Życie „uregulowane” działa lepiej niż „elastyczne” — choć początkowo mniej atrakcyjne.

04 ✎ Moja sytuacja — analiza

LICZBA EPIZODÓW W OSTATNICH 12 MIESIĄCACH

mania / hipomania / depresja / mieszane

AKTUALNE LEKI (Z DAWKAMI)

ANTYDEPRESANTY — KTÓRE, OD KIEDY

jeśli brane

TSH OSTATNIE BADANIE + WYNIK

SUBSTANCJE, KTÓRE MOGĄ NASILAĆ (ALKOHOL, KOFEINA, INNE)

CO CHCĘ OMÓWIĆ Z PSYCHIATRĄ

Klucz: Yatham CANMAT (2018): „rapid cycling wymaga **cierpliwego**, systemowego podejścia. Stabilizacja może zająć 6–12 miesięcy, ale jest osiągalna. Kluczowe: właściwe leki + rytmy społeczne + sen”.